TUBE DIGESTIF · DI-03

Appendicite aiguë · WSES 2025

WSES Jerusalem 2025
choix de l'imagerie, signes, formes compliquées

Démarche WSES 2025 : d'abord un **score clinico-biologique** (AIR, AAS chez l'adulte, PAS chez l'enfant). Risque faible : appendicite peu probable, observation. Risque intermédiaire : **imagerie** ou observation active. Présentation atypique : le **scanner** reste l'examen de référence (meilleure sensibilité).

CHOIX DE L'IMAGERIE SELON LE PATIENT

PATIENT	1RE INTENTION	SI NON CONTRIBUTIF OU DOUTE PERSISTANT
Adulte	**Scanner faible dose** (< 2–3 mSv) si disponible ; échographie + score en alternative	Scanner
Enfant, adolescent	**Échographie**	Scanner faible dose
Grossesse	Échographie	**IRM** (sans gadolinium)
Obésité (IMC ≥ 30), ≥ 65 ans	**Scanner**, de préférence faible dose, plutôt que l'échographie	—

SIGNES D'APPENDICITE

Échographie (compression graduée)

- Appendice **> 6 mm**, borgne, **non compressible**
- Paroi épaissie, hypervascularisée en Doppler
- Graisse péri-appendiculaire hyperéchogène
- Stercolithe : image hyperéchogène avec cône d'ombre
- Douleur au passage de la sonde

Scanner

- Appendice distendu **> 6 mm**, paroi épaissie et rehaussée
- Densification de la graisse péri-appendiculaire
- Épaississement du bas-fond cæcal
- Liquide de voisinage, ganglions réactionnels
- Injection IV ; opacification digestive non nécessaire

IRM (grossesse)

- Mêmes critères morphologiques que le scanner
- Hypersignal T2 de la paroi et de la graisse, restriction de diffusion
- Appendice normal : rempli d'air ou de contenu, < 6 mm

APPENDICITE COMPLIQUÉE : CE QUI CHANGE LA PRISE EN CHARGE

DÉFINITION WSES	SIGNES AU SCANNER	CONSÉQUENCE HABITUELLE
Perforation	**Défect focal de la paroi rehaussée** (signe le plus sensible), air extraluminal, stercolithe extraluminal	Chirurgie ; antibiothérapie postopératoire courte (2–3 jours)
Abcès	Collection péri-appendiculaire à paroi rehaussée (signe le plus spécifique) ; taille et accessibilité au drainage	< 35 ans : appendicectomie précoce. **≥ 35 ans** : traitement non opératoire puis **appendicectomie à 6–12 semaines** (néoplasie appendiculaire jusqu'à 14,3 %)
Péritonite diffuse	Liquide diffus, rehaussement péritonéal, pneumopéritoine	Chirurgie rapide
Gangrène étendue	Défaut de rehaussement pariétal	Chirurgie

Le **stercolithe** est un facteur de risque de perforation et d'échec du traitement antibiotique, mais il ne suffit pas à définir une forme compliquée. Avant appendicectomie différée après abcès : scanner (résolution) et coloscopie, surtout après 35 ans.

PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Appendice difficile à voir

- Position rétro-cæcale ou pelvienne : suivre le cæcum jusqu'à la base
- Appendicite de la pointe : examiner l'appendice sur toute sa longueur
- Appendice non vu sans signe indirect : n'exclut pas formellement, mais rend le diagnostic moins probable

Autres causes de douleur de la fosse iliaque droite

- Adénolymphite mésentérique, iléite infectieuse ou maladie de Crohn
- Torsion d'annexe, kyste rompu, grossesse extra-utérine
- Diverticulite droite, appendagite épiploïque, colique néphrétique

COMPTE RENDU

Appendice
vu ou non, position, diamètre

Inflammation
paroi, graisse, stercolithe (siège)

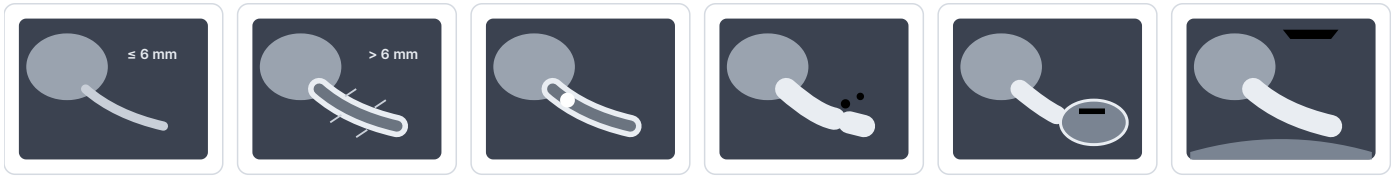
Complication
défect, air, abcès (taille, voie de drainage), liquide

Alternative
autre diagnostic si appendice normal

Appendicite aiguë · WSES 2025 (suite)

ATLAS VISUEL

Appendice au scanner : du normal au compliqué



Normale
air ou contenu, paroi fine

Non compliquée
distension, densification

Stercolithe
facteur de risque, non suffisant

Perforation
défect pariétal, air extraluminal

Abcès
collection à paroi rehaussée

Péritonite
liquide diffus ± pneumopéritoine

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris clair = paroi rehaussée, noir = air

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Appendicite : synthèse
Radiopaedia · écho, scanner, IRM
radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

Appendicite aiguë
Radiopaedia · article de référence
radiopaedia.org/articles/acute-appendicitis-2

Appendice perforé
Radiopaedia · signes de perforation
radiopaedia.org/articles/perforated-appendix

Stercolithe
Radiopaedia · aspect écho et scanner
radiopaedia.org/articles/appendicolith?lang=us

Perforation avec abcès (cas)
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/perforated-appendicitis-wi

WSES Jerusalem 2025
PubMed · recommandations
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/

Sources : Podda et al., WSES Jerusalem Guidelines 2025 (JAMA Surg 2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/ · Radiopaedia – perforated appendix – radiopaedia.org/articles/perforated-appendix · Radiopaedia – appendicitis (summary) – radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary